

Une personne autiste dans votre équipe de soins résidentiels

Pour le personnel infirmier des maisons de retraite et des centres de soins résidentiels — soutenir une personne autiste en soins assistés / établissement résidentiel / soutien intensif (tout âge).

L'idée principale

L'autisme, à travers le **monotropisme**, signifie que l'attention d'une personne se verrouille dans quelques « tunnels » profonds et intenses. Pour une personne autiste en soutien intensif, les environnements de soins et d'infirmerie sont souvent les **plus difficiles de tous** : hostiles sur le plan sensoriel, perturbant les routines, riches en contacts physiques et en demandes imprévisibles. Beaucoup communiquent sans parole et peuvent ne pas enregistrer ou signaler la douleur avant qu'elle ne soit sévère. Les priorités de soins sont claires : lire **tout comportement comme une communication sur un besoin non comblé**, rechercher d'abord la douleur et les causes physiques, protéger les routines et la volonté, et ne jamais supposer d'incapacité à partir d'une communication atypique.

Ce que vous pouvez observer — et ce qui se passe réellement

Vous pouvez observer...	Ce qui se passe souvent
« Comportement difficile », auto-mutilation, refus	Écrasante majorité de communication sur un besoin non comblé — douleur, peur, surcharge, perte de routine
Ne signale pas la douleur ; effondrement soudain / présentation tardive	Différences d' intéroception — les signaux internes peuvent ne pas être enregistrés avant d'être sévères
Meltdown ou shutdown pendant les soins	Réponse involontaire à la surcharge — <i>pas</i> de l'agression ou de la non-observance
Retrait lors de changements d'objets, d'ordre ou de personnel	Les routines et les possessions sont des ancres d'identité et de sécurité
Pas de parole fiable ; s'appuie sur la CAA ou un accompagnateur	Communication atypique ≠ manque de capacité ou de compréhension

Essayez ceci

- ▀ **Recherchez la douleur et les causes physiques en premier** pour toute nouvelle détresse — la constipation, les douleurs dentaires, les infections ou un équipement mal ajusté sont des coupables courants et cachés.
- ▀ **Bâissez les soins autour de la prévisibilité** : personnel constant, même séquence, supports visuels, préavis pour chaque changement.
- ▀ **Réduisez la charge sensorielle** — salle calme, lumière tamisée, réduction des bips et des odeurs fortes ; préservez les objets, intérêts et routines de la personne.
- ▀ **Utilisez la prise de décision assistée** et un profil de communication/sensoriel individualisé ; consultez l'accompagnateur de confiance.
- ▀ **Établissez un plan calme et écrit pour le meltdown/shutdown** : réduisez la stimulation, assurez la sécurité, donnez du temps et de l'espace — ne

contenez pas.

Évitez ceci

- Étiqueter la détresse comme « comportementale » avant d'avoir exclu la douleur et la surcharge.
- Utiliser la contention ou la sédation comme première réponse au meltdown/shutdown.
- Supprimer des routines, des objets ou des intérêts « pour leur propre bien », ou supposer un manque de capacité à partir d'une communication atypique.

Quand chercher plus de soutien

Traitez toute **détresse nouvelle ou croissante** comme un signal d'alarme médical jusqu'à ce que la douleur, l'infection, la constipation, les problèmes dentaires et les causes sensorielles/environnementales soient exclus. Dépistez le **burnout autistique** sous charge chronique. Impliquez des **équipes spécialisées en autisme/handicap mental** et en orthophonie (CAA). Gardez un « passeport santé/hospitalier » prêt pour toute admission.

Note sur le genre

Les femmes en soutien intensif sont particulièrement sous-identifiées et mal servies ; leur détresse est encore plus souvent mal interprétée. Appliquez la même rigueur pour exclure la douleur et la surcharge, quel que soit le mode de présentation ou de communication.

À propos de ce guide

Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — le **Guide pour les praticiens et les soins de santé** (Parties 3.5 & 4), le **Guide pour la famille** (Partie 5, maisons de retraite et hôpitaux) et la brève sur le **Monotropisme**. Utilisez le langage identitaire. **Informatif — ce n'est pas un avis médical ni un outil de diagnostic.** À adapter à l'individu.

Sources clés. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Kelly Mahler (2024, interoception/pain); Autism Society (2025, meltdowns/shutdowns); AASPIRE AHAT. Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.